

УДК:616.33-006.6-089:615.277

Е.Б.Ижсанов, Е.Ш. Абзалбек, С.К.Менбаев, М.С.Садық, Д.Акашева
Қазақтың онкология және радиология ғылыми зерттеу институты

Асқазан қатерлі ісігінің жергілікті таралған неоадьювантты химиотерапиясы

Тұжырым. Асқазанның жергілікті таралған қатерлі ісігі бар науқастарға арналған операция алдындағы химиотерапия туралы әдебиеттер көрсетілген. Асқазанның жергілікті таралған қатерлі ісігімен ауыратын 128 науқастың емнің салыстырмалы нәтижелері көрсетілген. Солардың ішінде 62 науқасқа неоадьюванттық терапия және оперативтік ем жасалған. Неоадьюванттық терапияның белгілі схемамен жүргізу 50% жағдайда ісіктердің әртүрлі дәрежедегі регрессиясына әкелді. Операциядан кейінгі асқынулар мен өлім санының көрсеткіштерінің артуы анықталмады.

Түйінді сөздер: асқазан қатерлі ісігі, неоадьюванттық химиятерапия, хирургиялық ем.

Асқазан қатерлі ісігі қазіргі таңда онкологияда маңызды және толық шешілмеген мәселелердің бірі болып келеді. Бұл обьектінің негізгі емі болып – хирургиялық әдіс болып табылады. Бірақ өлемде емнің кейінгі нәтижелері қанағатқа ілінер емес. Оның себептерінің бірі аурудың кеш диагностикасы және қазіргі кездегі емдеу әдістерінің мүлтіксіз дамымауына байланысты [1]. Қазіргі таңда 1-2 сатыдағы асқазан қатерлі ісігі бар науқастардың меншікті салмағы 20-25%-дан аспайды, ал 50% жағдайында науқастарда 3 сатыдағы ісіктік процесс анықталады. Сол себептен тек жергілікті хирургиялық емді қолдану тиімсіз болып табылады. Асқазан қатерлі ісігінің адьювантты (операциядан кейінгі) емнің көптеген зерттеуінде, аурудың рецидивсіз ағымын жақсартуында және жалпы өмір сүру ұзақтығы туралы нақты мәліметтері анықталған жоқ, сондықтан емдеудің жаңа әдістемелерін табуы аса маңызы зор. Асқазан қатерлі ісігінің емдеуінде операция алды немесе неоадьювантты химиотерапияның қолданылуына көп көңіл бөлініп келеді.

Неоадьювантты терапия негізгі ем түрінің алдында жасалынады. Осы емнің ортақшыларының көзқарасы бойынша негізгі шарттардың негіздемесі бұл, операция алдында қантамыр және лимфатикалық тамырлардың анатомиялық тұтастылығының сақталуы [2], яғни бұл операция алдындағы жүргізілетін жүйелі емнің ісікке тікелей және толық әсер етуіне ықпал жасайды. Сонын бәрі, біріншіден ісік көлемін кішірейтуге, ал ол аз көлемде операцияны жүзеге асыруға мүмкіндік береді; екіншіден метастазға ерте цитостатикалық әсер етуіне ықпал етеді.

Көбіне, науқастарға жасалынған көлемді операциядан кейін көптеген асқынулар байқалады (агастральды (резекциядан кейінгі), астеникалық синдром және т.б.), ал ол операциядан кейінгі кезеңнің ұзаруына себеп болады. Сол себептен кейбір науқастарға бастапқыдан адьювантты курстардың жүргізілуіне тиым салынады. Операция алды терапияның маңызы, науқастар операцияның өзін күтуімен

және емдеу барысында ақырғы жететін нәтижені күтуінде, бұл науқастарға қолайлырақ қабылданады. Сондай-ақ аса маңызды мезеттің бірі ол, ісіктің химиопрепараттарға жеке сезімталдығын анықтауда, ал ол кейінгі ем тактикасын анықтауға мүмкіндік береді.

Неоадьювантты химиотерапияның бірнеше спецификалық кемшіліктері бар: 1) негізгі ем мерзімінің ұзартылуы; 2) операция алдында жасалынған емнен кейін жеткен жақсы нәтижелерден және субъективті жалпы жағдайының жақсаруынан кейін, науқастардың радикалды емнен бас тартуының көбеюі; 3) химиопрепараттарға аз сезімтал клонды ісікті жасушалардың түзілуі.

Мюнстерде хирургиялық клиниканың ғалымы Н. Bunte асқазан қатерлі ісігі кезіндегі операция алды ХТ нәтижелерін зерттеген. Бұл автордың мәліметі бойынша біріншілік операцияға келмейтін 68 науқастың ішінен 19 науқасты НАХТ кейін операцияға келетін топқа көшірілді, және өмір сүру ұзақтығы 30 айға жетті [3].

Адхани и авторластары II-ші фазаның біртарапты сынағын жүргізді, бұл сынаққа асқазан қатерлі ісігі бар операцияға келетін 48 науқас енгізілді [4]. Операция алдында: этопозид, доксорубин және цисплатин тәсімі бойынша 3 курс ПХТ жүргізілді. ПХТ емінің аяғы кезінде резектабельділік 85% құрды, оның ішінен 77% науқастарға радикалды операция жасалынды. ХТ жасау барысында айқын токсикалық әсер байқалынды (негізінен, нейтропения), бұл токсикалық өзгеріс дәрілік препараттармен жойылды. Сынақ барысында 1 өлім ақырымен аяқталған уақытқа болды, асқынулар ХТ байланысты болды.

Кейіннен Ajani J.A. авторластармен балама режимде неоадьювантты 2 курс ПХТ-ны қолданылды (цисплатин, FU және этопозид) [5]. Жүргізілген оперативті емнен кейін сондай тәсімде 3 курс ПХТ жүргізілді. Барлық науқастарға операциялық ем жүргізілді, 72% науқастарда операция радикалды түрде жүргізілді. Зерттеу барысында 1 өлім ақырымен аяқталған уақытқа болды, асқынулар ХТ байланысты болды.

Leichman L. авторластармен алдын ала зерттеу нәтижелерін баяндады, бұл зерттеу баяндамасында 38 операцияға келетін асқазан ісігі бар науқастарға 2 курс операция алды химиотерапия жүргізілді (5- FU, лейковорин және цисплатин) [6]. Кейін науқастарға операциядан кейінгі интраперитонеальды химиотерапия (FUDR, цисплатин және көктамыр ішіне натрий тиосульфаты) жүргізілді. Нәтижесінде науқастардың ішінен 92%-на лапаротомия жасалынды, оның ішінен 87% операцияға келетін топты құрды. Операциядан кейінгі интраперитонеальды химиотерапия зерттелінген науқастардың 68% жасауына мүмкіндік болды. Зерттеу барысында 1 өлім ақырымен аяқталған уақытқа болды, ол жүргізілген еммен байланысты болды. Сондай-ақ зерттеу барысында ұйымдастырылу тәртібі бұзылғаны анықталды: 1-шіден зерттеу басында ісіктің клиникалық сатысын КТ немесе эндоскопиялық зерттеу әдісімен анықтау жасалынбады; операциядан

кейінгі морфологиялық зерттеу 14 науқаста аурудың 0 немесе I сатысын көрсетті. 7 науқаста ісіктің II сатысына сай келетінін көрсетті.

Krookes J.E. авторластармен зерттеудің II-ші фазасының алыстанған нәтижелерін баяндады [7]. Баяндаманың қорытындысында асқазан қатерлі ісігі бар неоадьювантты химиотерапиямен құрамдастырылған емді алған 59 науқас жайында мәлімет берілген. Резектабельділіктің дәрежесі 71% құрды. Операциядан кейінгі өлім 5% құрды. Бұл топ науқастардың өмір сүру медианасы 4 жылдан аса деп бағаланды. Себебі бұл науқастарға операция алды лапароскопия жасалмады, сондықтан ісіктік процесстің таралу дәрежесін анықтауға мүмкіндік болмады, яғни бұл зерттеуде жергілікті таралған және ерте сатыдағы ісіктері бар науқастар болуы ықтимал.

Kelsen D. авторластарымен 2 зерттеу жүргізді, бұл зерттеу операция алды химиотерапияның жасалуына, кейіннен операциядан кейінгі интраперитонеальды химиотерапияны жасауға негізделген [8]. Бірінші зерттеуде FAMTX режимінде операция алды және операциядан кейінгі интраперитонеальды режим - FU + цисплатин. Зерттеу тобына 56 науқас кірді, операция алдында КТ және эндосонография негізінде T2-4 дәрежелі инвазиясы анықталынды. Кейіннен морфологиялық зерттеу негізінде басым көпшілігі IIIA немесе IIIB сатысы сәйкес келетіні дәлелденді. ХТ токсикалық әсері айқын болмады, негізгі жағымсыз әсерлердің бірі, бұл – нейтропениялық қызбамен көрініс беретін – миелосупрессия (60% науқаста). Аурудың сатысының төмендеуі 51% науқаста байқалынған, операцияға келетін науқастар деңгейі – 89%, резектабельділіктің деңгейі – 74% (61% радикалды және 20% - паллиативты). Өмір сүру медианасы барлық науқастарда 15,3 айды құрды.

Кейінгі зерттеулер тобына 35 науқас кірді [9], оларға операция алды 2 курс химиотерапия: цисплатин және FU, кейіннен операциядан кейінгі интраперитонеальды флоресоредин және лейковорин дәрілік препараттарымен емдеу кіреді. Барлық науқастарға емдеу басында лапароскопия және асқазанның эндосонографиясы жасалынды, бұл науқастарда T3 инвазивті ісіктік үрдістер немесе метастатикалық лимфотүйіндер бар ісіктік үрдістер байқалған. Операция алды химиотерапияның токсикалық әсері айқын болмады. Өлім ақырлары болған жоқ. Резектабельділік 82% құрды; орташа өмір сүру ұзақтығы 22,6 айды құрды.

Cunningham D. авторластарымен (MAGIC Trial) ≥PA сатысындағы ісіктік процесстік науқастарға ECF-режиміндегі химиотерапия әсерінің рандомизирленген зерттеуін жүргізді [10]. Зерттеуге 503 клиникалық науқас енгізілді, оның ішінде асқазанның әр түрлі бөлімінің зақымдануымен 74% (гистологиялық тұрғыдан – аденокарциномамен берілген); 11% жағдайында кардиоэзофагеальды карциномамен (аденогенді гистологиялық вариантымен), және 15% жағдайында өңештің төменгі кеуделік бөлімінің және өңештің абдоминальды бөлімінің аденокарциномасымен берілген. Науқастарға 3 курс операция алды жүйелі терапия (эпирубицин, цисплатин және фторурацил) жүргізілді. Неоадьювантты терапиядан кейін операциялық ем жүргізілді, содан соң науқастарға тағы сол тәсілмен 3 курс адьюванттой полихимиотерапия жасалынды. Бақылау тобын тек хирургиялық ем қабылдаған науқастар құрды. Зерттеу басында операциядан кейінгі асқынудың және өлім көрсеткіштерінің көбеюін болжамады. Зерттеу тобы науқастарының 5 жылдық өмір сүру көрсеткіштері талқыланды. Полихимиотерапия жасалынған топтың 5 жылдық өмір сүру көрсеткіштері 36% құрса, тек хирургиялық жолмен емделген топтың 5 жылдық өмір сүру көрсеткіштері 23% құрды. Авторлармен рецидивтердің

және ісіктік процесстің үдеуінің даму мерзімдерінің күрт көбейгенін байқады.

Ұлыбританияның периоперативті полихимиотерапияның MAGIC эффективтілікті зерттеу 2007 жылдың 2-ші тоқсанында NCRI ST03 кодтық атағына ие болды. Бұл ассоциациялық зерттеу Ұлыбританияның көмегімен ашылған Халықаралық сайттар көмегімен асқазанның және кардиоэзофагеальды аймақтың аденокарциномасының резектабельды түрлерін 1100 санына дейін жеткізілуіне негізделген (тип III Siewert), олар периоперативті химиотерапия ECX (эпирубицин, цисплатин, капецитабин) бойынша рандомизациялық жолға ұшырайды, сондай-ақ антиваскулярлы эндотелиальды өсу факторы (VEGF) моноклональды антидене бевацизумаб (авастин). ECX тәсімінің бұл зерттеуге таңдауы, капецитабиннің ұзақ жол ауыз арқылы қолданылуына қолайлы болуында, ал ол 5FU-дың орын басуына және оның ұзақ енгізілу қолайсыздығын қамтамасыз етеді. Науқастардың ем нәтижелерін жақсартудағы проспективті үміттер бар.

Зерттеудің операция алды эффективтілігі 2 тармақтық француздық [11] топ құрды: біріншісі бұл – тек хирургиялық емге ұшыраған науқастар ($n=111$) және негізгі топты жергілікті таралған асқазақ қатерлі ісігі бар науқастар құрды ($n=113$), оларға операция алдында 5-фторурацил + платинол тәсімі бойынша 2 курс химиотерапия және операциядан сол тәсілмен 4 курс химиотерапиясы жүргізілді. Өкінішке орай бұл зерттеу толық қамтылған деп айта алмаймыз, себебі науқастар операцияға дейін және операциядан кейін химиотерапияның әртүрлі сан курстарын алуына байланысты. Сонымен қатар құрама ем алған топ науқастардың 5 жылдық рецидивсіз өмір сүруі, тек хирургиялық ем қабылдаған топ науқастарына қарағанда біршама жоғары болғанын көрсетті (құрама ем алғандар 34%, хирургиялық ем алғандар 21%; $p=0,0033$). Сондай-ақ қосарланған ем алған топ науқастарда жалпы өмір сүру көрсеткіштерінің, тек хирургиялық ем қабылдаған топ науқастарына қарағанда біршама жоғары болғанын көрсеткен (құрама ем алғандар 38%, хирургиялық ем алғандар 24%; $p=0,021$). Операция алдында тағайындалған химиотерапияның ағымы, операциядан кейінгі тағайындалған ХТ қарағанда науқастарда жеңілдірек өтеді. Авторлардың қорытындысы бойынша неоадьювантты полихимиотерапия асқазанның жергілікті таралған қатерлі ісігінің стандартты емі болуы шешіміне келді.

Қазақтың онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының асқазан-ішек жолының онкологиясы бөлімшесінде асқазанның жергілікті таралған қатерлі ісігі бар 128 науқастың емдеу эффективтілігінің салыстырмалы зерттеуі жүргізілді, олардың ішінен 62 науқасқа (негізгі топ) құрама ем жүргізілді – неоадьювантты полихимиотерапия + операция, және де 66 науқасқа тек хирургиялық ем жүргізілді. Қосарланған ем жүргізілген топ науқастардың орта жасы $50,0 \pm 21,48$ жасты, ал хирургиялық ем алған топ науқастарда – $57,5 \pm 20,51$ жасты құрды. Полихимиотерапия тәсімі: таксотер- 75 мг/м² 1 күн + 5-фторурацил 500 мг/м² 2-5-ші күн аралығында + лейковорин 50 мг/м² 2-5-ші күн аралығында жүргізілді.

Нәтижелері: 128 науқастарға толық гастрэктомия жасалынды, соның ішінде хирургиялық емнен кейінгі 91% жағдайында және құрама емнен кейінгі 88% жағдайында құрама операциялар жасалынды. Хирургиялық емнен кейінгі 66 науқастар ішінен 16 науқаста $19(28,8 \pm 0,46)$ түрлі асқынудан байқалды. Солардың ішінен ең жиі – (4 асқынудан) операциядан кейінгі панкреатит және операциядан кейінгі пневмония ($6,1 \pm 0,24$). 2 жағдайда ($3,0 \pm 0,17$) операциядан кейінгі ерте кезеңде – операциядан кейінгі қаңсырау байқалынды. 2 жағдайда өңеш-ішектік тігістерінің

дөрменсіздігі ($3,0 \pm 0,17$) байқалған.

Құрама ем алған 62 науқастарда операциядан кейін 15 жағдайында асқынулар байқалған. Асқыну саны 18 ($29,0 \pm 0,46$). Бұл топта да операциядан кейінгі пневмониямен панкреатит асқынулары дамыған ($8,0 \pm 0,27$ және $6,2 \pm 0,25$ сәйкес). Өңеш-ішектік тігістерінің дөрменсіздігі 2 жағдайда ($3,2 \pm 0,18$) байқалған.

Асқазанның жергілікті таралған қатерлі ісігінің толық гастрэктомия операциясы жасалған 128 науқастың ішінен, 4 науқасы қаза тапты. Жалпы өлім көрсеткіші 3,1% құрды. Зерттелген 2 топта да, 2 жағдайында өлім көрсеткіштері шамамен бірдей келеді ($3,2 \pm 0,18\%$ и $3,0 \pm 0,17\%$ сәйкес).

128 науқастың ішінен 124 науқаста операциядан кейінгі кезеңнің және толық емделіп шыққан науқастардың 1 жылдық өмір сүру көрсеткіштері тексерілді. Хирургиялық топты 64 науқас құрған, құрама емнен кейінгі 60 науқастың 2 жылдық және алыстаған 5 жылдық өмір сүру көрсеткіштері тексерілді.

Алыстанған нәтижелерді зерттейтін авторлардың деректері бойынша, хирургиялық емнен кейін, науқастарда аурудың қайталануы мен метастаздардың 50% операциядан кейінгі бірінші екі жылда пайда болады. Асқазан обырының III және жағары сатысымен ауыратын науқастар үшін бұл мерзім қысылшаң болып саналады. 1 кестеде екі жылдық өмір сүру көрсеткіш мәлеметтері көрсетілген.

Кесте 1- Зерттелінген науқастар тобының 2-жылдық өмір сүру көрсеткіштері

Емдеу әдісі	Науқастар саны	Өлім көрсеткіштері	2-жылдық өмір сүру көрсеткіштері	Рецидивсіз 2-жылдық өмір сүру көрсеткіштері
Хирургиялық	64	33	31 ($48,4 \pm 5,03$)	26 ($41,6 \pm 4,95$)
Құрама	60	28	32 ($53,3 \pm 5,03$)	28 ($46,7 \pm 5,03$)

Құрама емнен кейін метастазсыз және ауру қайталануынсыз екі жылдық мерзімнен артық өмір сүрген науқастардың саны артқаны байқалды – $41,6 \pm 4,95$ тен $46,7 \pm 5,03$ дейін. Сонымен қатар құрама ем алған науқастар тобында өмір сүру көрсеткішінің хирургиялық ем кезіндегі $48,4 \pm 5,03$ тен $53,3 \pm 5,03$ дейін көтерілгені байқалды.

124 науқаста бес жылдық өмір сүру көрсеткішінің нәтижелері зерттеп тексерілді. (2 кесте).

Кесте 2 - Зерттелінген науқастар тобының 5-жылдық өмір сүру көрсеткіштері

Емдеу әдісі	Науқастар саны	Өлім көрсеткіштері	5-жылдық өмір сүру көрсеткіштері	Рецидивсіз 5-жылдық өмір сүру көрсеткіштері
Хирургиялық	64	53	11 ($17,2 \pm 3,80$)	10 ($15,7 \pm 3,65$)
Құрама	60	47	13 ($21,7 \pm 4,15$)	11 ($18,3 \pm 3,90$)

Хирургиялық ем болған науқастар тобында қазіргі уақытта 11 науқас тірі ($17,2 \pm 3,80$). Ал құрама ем алған науқастар тобында бес жылдық өмір сүрі корсеткішін 13 науқас ($21,7 \pm 4,15$) бастан өткізді. Сонымен қатар ауру қайталануынсыз бес жылдық өмір сүру көрсеткіші, қосрланған ем алған науқастар тобында ($18,3 \pm 3,90$) тек хирургиялық ем алған науқастар тобына ($15,7 \pm 3,65$) қарағанда жоғары. Алғашқы екі жыл және кейінгі үш жылдықты салыстырғанда, қосрланған ем және хирургиялық ем алған науқастар тобында өлім қарқынының төмендеуі байқалады. Егер хирургиялық

және қосарланған ем алған науқастар тобында бірінші 2 жылда 51,6% және 46,7% науқастар қайтыс болса, кейінгі жылдары ол көрсеткіш 31,3% және 30,0% құрады. Бұл көрсеткіштер радикалды емнен кейінгі науқастардың бастапқы екі жылдықтағы ісіктік процесстің үдеуінің және өлім көрсеткіштерінің жиілену туралы әдеби деректерге сәкес келеді.

Асқазанның жергілікті таралған қатерлі ісігі түрімен ауыратын 128 науқасқа хирургиялық ем жүргізілді. Соның ішінде 59 науқасқа D2 лимфодиссекция және 69 науқасқа D3 лимфодиссекция жасалынды.

Жиілік және операциядан кейінгі асқынулар анализі, статистикалық дәлелденбеген, D3 лимфодиссекция болған науқастар тобында операциядан кейінгі асқынулардың жоғарлауын көрсетті: 30,3% қарсы 27,1%. Өр деңгейдегі лимфодиссекцияның арнамалы асқынулары байқалмаған.

Кесте 3 - D2 және D3 лимфодиссекциясы жасалған науқастар тобындағы екі жылдық өмір сүру көрсеткіштері

Лимфо-диссекция көлемі	Науқастар саны	Өлім көрсеткіштері	2-жылдық өмір сүру көрсеткіштері	Рецидивсіз 2-жылдық өмір сүру көрсеткіштері
D2	57	28	29 ($50,9 \pm 5,04$)	27 ($47,3 \pm 5,03$)
D3	67	33	34 ($50,7 \pm 5,04$)	31 ($46,2 \pm 5,02$)

Кестеде көрсетілгендей жергілікті таралған асқазан қатерлі ісіктері бар науқастарда D2 және D3 лимфодиссекциясының қолданылуында 2-жылдық өмір сүру көрсеткіштерінің аса айырмашылығы байқалмайды ($50,9 \pm 5,04$ – $50,7 \pm 5,04$ сәйкес). Рецидивсіз 2-жылдық өмір сүру көрсеткіштерінің де айырмашылықтары аса байқалмайды ($47,3 \pm 5,03$ – $46,2 \pm 5,02$ сәйкес).

124 науқаста ем нәтижелерінің 5-жылдық өмір сүру көрсеткіштері тексерілген (кесте 4).

Кесте 4- Зерттелінген науқастар тобының 5-жылдық өмір сүру көрсеткіштері

Емдеу әдісі	Науқастар саны	Өлім көрсеткіштері	5-жылдық өмір сүру көрсеткіштері	Рецидивсіз 5-жылдық өмір сүру көрсеткіштері
D2	57	46	11 ($19,3 \pm 3,98$)	9 ($15,8 \pm 3,67$)
D3	67	54	13 ($19,4 \pm 3,98$)	12 ($18,0 \pm 3,86$)

Қазіргі таңда D2 лимфодиссекциясы жасалынған топ науқастардың ішінде тірісі 11 адам ($19,3 \pm 3,98$), ал D3 лимфодиссекциясы жасалынған топ науқастарда - 13 ($19,4 \pm 3,98$) адам. Рецидивсіз 5-жылдық өмір сүру көрсеткіштері D3 лимфодиссекциясы жасалынған топ науқастарда көбірек болғаны байқалады, бірақ статистика тұрғыдан дәлелденбеген ($p > 0,05$) - $18,0 \pm 3,86$ – $15,8 \pm 3,67$ D2 лимфодиссекциясының тобы.

Сонымен, жергілікті таралған асқазан қатерлі ісігі бар науқастарға неоадьювантты полихимиотерапияның жүргізілуі стандартты емге қарағандағы нәтижелерден төмен емес, жасалынған емнің алыстанған нәтижелерін жақсартатынын байқаймыз. Жергілікті таралған асқазан қатерлі ісігі бар науқастарға жасалынған D2 және D3 лимфодиссекциясы кезіндегі алыстанған нәтижелерінің айырмашылығы байқалмады, яғни суперкеңейтілген лимфодиссекцияның орындалуының маңызы жоқ деп айтуға болады.

Әдебиет тізімі

- 1 Noguchi Y., Imada T., Matsumoto A. et al. Radical surgery for gastric cancer. A review of the Japanese experience // *Cancer*.-1989.-Vol. 64.-P.2053.
- 2 Neg N.G., Husband J.F., MacVicar A.D. et al. Correlation of CT with histopathological findings in patients with gastric and gastro-oesophageal carcinomas following neoadjuvant chemotherapy // *Clin. Radiol.*- 1998.- Vol. 53.-P.422.
- 3 Gastrointestinal Tumor Study Group. The concept of locally advanced gastric cancer // *Cancer*.- 1990.- Vol. 66.-P.2324.
- 4 Ajani J.A., Ota D.M., Jessup J.M. et al. Resectable gastric carcinoma. An evaluation of preoperative and postoperative chemotherapy // *Cancer*.- 1991.- Vol. 68.-1501.
- 5 Ajani J.A., Mayer R.J., Ota D.M. et al. Preoperative and postoperative combination chemotherapy for potentially resectable gastric carcinoma // *J. Natl. Cancer Inst.*- 1993.- Vol. 85.-P.1839.
- 6 Leichman L., Silberman H., Leichman C.G. et al. Preoperative systemic chemotherapy followed by adjuvant postoperative intraperitoneal therapy for gastric cancer: a University of Southern Caledonia pilot program // *J. Clin. Oncol.*- 1992.- Vol. 10.-P.1933.
- 7 Krookes J.K., O'Connell M.J., Wieand H.S. et al. A prospective, randomized evaluation of intensive-course 5- fluorourasil plus doxorubicin as surgical adjuvant chemotherapy for resected gastric cancer // *Cancer*.- 1991.- Vol. 67.-P.2454.
- 8 Kelsen D., Atiq A., Saltz L. et al. FAMTX (fluorouracil, methotrexate, Adriamycin) is as effective and less toxic than EAP (etoposide, Adriamycin, cisplatin): a random assignment trial in gastric cancer// *Proc. ASCO*.- 1991.-N10.-P.137.
- 9 Kelsen D., Karpeh M., Schwartz G. et al. Neoadjuvant therapy of high-risk gastric cancer: a phase II trial of preoperative FAMTH and postoperative intraperitoneal fluorouracil-cisplatin plus intravenous fluorouracil // *J. Clin. Oncol.*- 1996.- Vol.14.-P.1818.
- 10 Cunningham D., Rao S., Starling N. et al. Randomised multicentre phase III study comparing capecitabine with fluorouracil and oxaliplatin with cisplatin in patients with advanced oesophagogastric cancer: the REAL 2 trial // *Proc. Am. Soc. Clin. Oncol.*- 2006.- Vol. 25.- 182 S.
- 11 Leong T., Michael M., Foo K. et al. Adjuvant and neoadjuvant therapy for gastric cancer using epirubicin / cisplatin / 5-fluorouracil (ECF) and alternative regimens before and after chemoradiation // *Br. J. Cancer*.- 2003.- Vol.89, N 8.-P. 1433-1438.

Аннотация

Е.Б.Ижсанов, Е.Ш. Абзалбек, С.К.Менбаев, М.С.Садық, Д.Акашева

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Неоадьювантная химиотерапия местнораспространенного рака желудка

Приведен литературный обзор актуальности проведения предоперационной химиотерапии для больных местнораспространенным раком желудка. Представлены сравнительные результаты лечения 128 больных местнораспространенным раком желудка, из которых 62 проведена комбинация неоадьювантная терапия и операция. Применение схем неоадьювантной терапии в 50% случаев привело к различной степени регрессии опухоли. Не выявлено увеличения показателей послеоперационных осложнений и летальности.

Ключевые слова: рак желудка, неоадьювантная химиотерапия, хирургическое лечение

Summary

Y. B. Izhanov, E. Sh. Abzalbek, S. K. Menbayev, M. S. Sadyk
Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Neoadjuvant chemotherapy of the locally advanced gastric cancer

Comparative results of treating 128 patients with locally advanced gastric carcinoma, of which 62 carried a combination of neoadjuvant therapy and surgery. In-off's schemes neoadjuvant therapy in 50% of cases led to varying degrees of tumor regression. There is no evidence the increasing rate of postoperative complications and mortality.

Key words: gastric cancer, neoadjuvant chemotherapy, surgical treatment